ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

消化管出血・ストレス潰瘍予防 — 要約

解説「消化管出血・ストレス潰瘍予防」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。肝硬変の全身管理は「ICUの肝障害と肝不全」の要約へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

緊急度は初期蘇生への反応で分ける

安定していれば上部内視鏡は24時間以内でよい。待つ間の3条件が前提

出血源と機序で手を変える

血便＋不安定はまず上部。静脈瘤は圧の病気で、FFPとトラネキサム酸は使わない

予防は絞って始め、退室時に止める

PPIで出血は減るが死亡は変わらない。害の大半は止め忘れ

2 最初の10分 — 蘇生と評価を同時に

詳しく

静脈路2本・血算・凝固・血液型・病歴（抗血栓薬・NSAIDs・肝疾患）と並行して初期蘇生、GBSを数える

▼

反応しない（ショックが続く）

- 緊急内視鏡・IVR・手術。「24時間以内でよい」は当てはめない
- 血便でもまず上部内視鏡（血便の約15%は上部由来）

反応して安定

- 吐血・黒色便：GBS 1以下は低リスク、7以上は内視鏡治療の可能性。コンサルト後24時間以内
- 血便：前処置（PEG 4〜6 Lを3〜4時間）で非緊急の大腸内視鏡。重症で続けばCTA→陽性ならIVR

肝硬変・静脈瘤出血の既往があれば、どの枝でも内視鏡を待たずに血管作動薬と抗菌薬を始める

- **輸血はHb 7**：心血管虚血・大量出血・介入の遅れでは9。INR 1.5〜2.5なら拮抗を待たずに内視鏡、2.5超は先に拮抗を考える。止血が要る重症出血では血小板5万/μLを保つ
- **トラネキサム酸は使わない**：HALT-IT（12,009例）で死亡は減らず、静脈血栓0.8%対0.4%、けいれん0.6%対0.4%に増えた

3 上部消化管出血 — 待つなら条件を書く

詳しく

事実	数字	使い方
急いでも減らない	安定したGBS 12以上の516例。6時間以内と6〜24時間で30日死亡8.9%対6.6%、再出血10.9%対7.8%	GBSで時間を決めない。ショックが続く患者は対象外
待つ3条件	PPI 80 mgボーラス→8 mg/時、再出血の監視、緊急内視鏡へ移れる24時間体制	開始時刻・再出血の兆候・内視鏡の予定時間帯をカルテに書く
静脈瘤は圧の病気	血管作動薬と抗菌薬を2〜5日、Hb 7〜8、12時間以内の内視鏡	FFP・トラネキサム酸・Hbを正常まで戻す輸血はしない。効かなければTIPSを相談

FFPは静脈瘤出血の止血失敗と42日死亡に関連した。肝硬変の出血は急性代償不全の入口で、その後の管理は肝不全の資料に任せる。

4 下部と小腸の出血

詳しく

- **緊急大腸内視鏡は推奨から外れた**：ACG 2023は非緊急を推奨し、24時間以内の大腸内視鏡は撤回。前処置なしの大腸内視鏡・S状結腸鏡はしない
- **上下部が陰性なら小腸出血疑い**：小腸出血は全消化管出血の5〜10%。安定ならカプセル内視鏡を48時間以内、不安定なら多相CTA
- **止血した後**：アスピリンは遅くとも7日以内に再開。経腸栄養を控えるのは48〜72時間で十分で、再開の予定日を最初に書く

5 ストレス潰瘍予防（SUP）— 絞って始め、退室時に止める

詳しく

- **出血するのは重症度の高い患者**：116,497例のSRで人工呼吸は予測因子に残らず、凝固障害・ショック・AKI・慢性肝疾患が残った
- **始める基準**：REVISE基準（侵襲的人工呼吸が翌暦日を越えて続く見込み）か、SUP-ICU基準（ショック・RRT・24時間超の人工呼吸・凝固障害・抗凝固薬・肝疾患のどれか）。活動性出血や最近の潰瘍は「治療」として書き分ける
- **効果は出血だけ**：SUP-ICU（3,298例）でパントプラゾール40 mg/日は出血4.2%→2.5%（RR 0.58）、90日死亡30.4%対31.1%。重症度サブグループの割れはSUP-ICUとREVISEで向きが逆で、運用を変える根拠にならない
- **薬はPPI**：H2ブロッカーは第二選択。肝硬変ではPPIがSBPのリスクを上げるので、適応が切れたら止める
- **止めるのはICU退室時**：退室後の継続は肺炎・心血管イベント・2年死亡の増加と関連。「経腸栄養が入ったら止める」は根拠にならない

- ☐ **開始の指示**と同時に見直す時点を書く
- ☐ **人工呼吸だけ**でSUPを決めない
- ☐ **退院処方**にICU由来のPPIが残っていないか
- ☐ **静脈瘤**にFFP・トラネキサム酸を出さない

出典：本編の主要文献（Lau NEJM 2020；ACG 2016・2023；HALT-IT（Clin Crit Care 2026の総説）；Kim KJIM 2026；van den Boom IJLH 2022；Van Eldere Anaesthesia 2023；Perricone ICM 2023；SUP-ICU NEJM 2018；REVISE NEJM 2024；Young ICM 2024；Granholm ICM 2019 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。